

NOTULEN

HARI/ TANGGAL : SELASA / 13 FEBRUARI 2024
 PUKUL : 10:00 WIB – SELESAI
 MATERI : LAPORAN BULANAN JANUARI (RS)
 TEMPAT : HALL SAKURA LANTAI 5

Berikut hasil notulen :

NO.	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Target Rumah Sakit	Perbedaan Target untuk tiap Rumah Sakit dan Klinik	Disesuaikan dengan kondisi dari Rumah Sakit maupun Klinik Koordinasi dengan Keuangan dan Rumah Sakit Supervisi turun ke lapangan harus dilaksanakan agar tau kondisi nyata di pelayanan	Manajerial Rumah Sakit
2.	Prima Husada Malang	1. Progres hasil IGD masih perlu di evaluasi	1. IGD peningkatan 50 pasien per hari tetapi belum di breakdown terkait apakah memang emergency	Direksi PHM
		2. Rawat Jalan meningkat	2. Koordinasi dengan DPJP tidak boleh ada kunjungan yang sama dari rawat jalan ke rawat inap	
		Rawat inap Strategi Rumah Sakit	Peningkatan kunjungan rawat inap dan rawat jalan 1. Penurunan pada pasien jasa raharja (mengaktifkan humas marketing untuk koordinasi) 2. Pasien BPJS → DPJP miss dengan masalah ventilator sehingga dilakukan koordinasi sehingga masalah rujukan ventilator menurun. Saran: lakukan Analisa lebih lanjut terkait ventilator 3. Penunjukan dpjp utama di IGD	Direksi PHM
		Kunjungan Pasien	Kunjungan pasien untuk bulan januari terkait pelayanan (kerja sama dengan marketing terkait kenaikan)	Direksi PHM dan Humas Marketing

		Proporsi	Rumah sakit sudah lebih leluasa dengan kondisi proporsi yg sudah surplus positif Untuk dokter bedah: harusnya lebih mudah karena Tindakan sudah jelas (control pada komponen Tindakan)	Direksi PHM
		Klaim	Tidak perlu dimasukkan di Rapat Bulanan. Apabila memang harus dimasukkan dalam lapbul lebih ke performa Rumah Sakit (apabila ini 1. Strategi tidak boleh mengakali aturan (cari kepastian lakukan lagi 3 sampai 4 kali rujukan internal pada hari yang berbeda apabila memang pasti tidak boleh oleh BPJS, keluarkan kebijakan)	Direksi PHM
		Kepuasan Pasien	Kepuasan pasien di compare dengan acuan BPJS	Direksi PHM
		Kebijakan Rumah Sakit	Rumah Sakit harus memiliki kebijakan dan sosialisasi disesuaikan dengan standar yang ada. Kepuasan pasien perbaiki sesuai dengan saran (dimulai dari atasan) Gunakan ventilator sesuai dengan kebijakannya Dua rumah sakit berkoordinasi untuk betukar pikiran terkait permasalahan di ICU	Direksi PHM
4.	Prima Husada Sukorejo	1. Strategi RS dan humas marketing saat bulan puasa	1. Pelaksanaan MCU untuk segera di galakkan sehingga saat ada penurunan kunjungan ketika puasa sudah ada penambalan dari kunjungan kunjungan yang lain 2. Perlu dilakukan pengaturan reservasi pasien 3. Perbaikan dan pemerataan slot DPJP disesuaikan dengan kondisi pasien yang ada di PHM	Direksi PHS dan Humas Marketing

			- Promosi oleh marketing terkait pelayanan yg ada di Prima Husada Sukorejo - Pembuatan ruang tunggu untuk pasien pulang sehingga moving pada rawat inap lebih cepat - Dilakukan push sebelum maret dan April untuk menambal - Marketing selalu mengawal semua kegiatan terkait Perusahaan - Observasi yang tidak terlalu berat → tidak menerapkan nunggu balasan DPJP di sesuaikan dengan dokter IGD untuk dinaikkan ke ruangan - TT ekstra bed selalu stand by - Pasien rujuk di loading kan ke ICU untuk menunggu	
		Laporan Tahunan dan Program Kerja Rumah Sakit	Belum diterima untuk kedua Rumah Sakit segera di kirimkan Pembuatan dilaksanakan oleh jajaran direksi bukan sekretaris Laporan kabid juga di lengkapi. Unggulan dan pengembangan harus dilampirkan	Direksi PHS
		Meningitis	Kemajuan dari program meningitis	Direksi PHS
		Peningkatan kunjungan	Saran: coba terima semua penawaran terkait ambulance pada kegiatan mudik Kunjungan IKO: - Bedah mulut bisa dilihat untuk penambahan Bedah Mulut sebagai strategi penambahan pasien iko - Coba tingkatkan ketertarikan DPJP untuk pembukaan Poli Malam - Penambahan slot kosong ditawarkan ke DPJP lama sebelum menawarkan ke dokter lain	Direksi PHS dan Humas Marketing
		Target RS	PHS → pendapatan bulanan Rumah Sakit minimal 13,8 PHS 2023 turun dari tahun 2022 (kinerja MCU) sehingga untuk	Direksi PHS

			pemenuhan hanya linear di tahun 2024 tidak layak mendapatkan reward sehingga diusahakan terlebih dahulu untuk memenuhi target minimal linear → 158 miliar RS harus tahu posisi keuangan → perlu di rapatkan dengan keuangan di masing-masing RS dilaksanakan perbulan (pembuatan grup untuk pelaporan setiap bulan oleh keuangan PT untuk keuangan RS)	
5.	Satu Sehat	PHS	1. Terinfo terkait 31 maret batas akhir untuk bridging dengan satu sehat 2. Prima Husada Malang pertemuan di Atria sehingga IT diberi kemudahan untuk production satu sehat untuk PHS tidak ada tetapi akan diajukan dan progress untuk production (target bulan februari) PHM Timeline bisa langsung diinformasikan apa saja yg dibutuhkan oleh programmer untuk pelaksanaan progress dari PHM PT 1. Apabila sudah selesai bridging (lebih di fokuskan di Rekam Medis) 2. Gambaran satu sehat dan perbedaan beserta potensinya (satu sehat bertujuan untuk agar setiap orang tau Riwayat kesehatannya masing-masing dan penjamin bisa saling berkoordinasi termasuk asuransi swasta) 3. Kemenkes sudah menggunakan standar internasional terkait satu sehat 4. Hal hal yg harus di antisipasi terkait satu sehat (data harus sudah fix sehingga diagnose sudah	Direksi RS PT dan Programmer



			final antar RS dan penjamin) 5. Standar diagnosis akan digunakan (PR harus memahami dua standar yg akan digunakan dan akan diinput dua duanya) 6. SK TT dilakukan pendekatan seperti HAFIS karena sering berubah 7. Program – program harus dikawal oleh RS sesuai dengan timeline 8. Harus berlajan sesuai dengan kebijakan yg diberikan kepada kita	
--	--	--	--	--

Pemimpin Rapat
Komisaris Utama PT. Disa Prima Medika

dr. Sadi Hariono, MMRS

Malang, 25 Januari 2024
Notulis

Adinda Lestari Putri, S.KM

Mengetahui,
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika

Endang Susilowati